

## 一、疾病理解與病理機轉

末期腎臟疾病是腎臟功能逐漸衰退到第五期的嚴重狀況,這時候腎臟已經無法有效清除身體內的廢物和維持酸鹼平衡,導致血液中的尿毒指數不斷升高。這會讓身體慢慢出現尿毒症的各種症狀,包括因為體液積聚造成的呼吸困難、全身水腫和高血壓,以及皮膚搔癢、噁心嘔吐、疲勞無力、營養不良和貧血等問題。當腎臟功能嚴重受損時,通常需要透過透析治療或腎臟移植來代替原本的腎臟功能。

## 二、藥物知識與服藥遵從

1. 請務必按照醫師指示規律服用所有處方藥物,不可自行調整劑量或停藥。
2. 降磷藥物需要咬碎後與食物一起服用,每吃一兩口食物就配上一小塊藥物。
3. 避免自行服用止痛劑或來路不明的藥物,這些可能對腎臟造成額外負擔。
4. 服用藥物後若出現不適症狀,應立即告知醫護人員。
5. 記錄長期用藥情況,就醫時主動告知醫師目前服用的所有藥物。

## 三、警訊辨識與處置行為

1. 如果出現意識改變、神智不清的情況,請立即就醫。
2. 持續噁心、嘔吐、食慾不振、異常疲倦或腹瀉時需要緊急返院。
3. 胸悶、呼吸困難或呼吸短促加重時應立即尋求醫療協助。
4. 發現下肢水腫加劇或體重異常快速增加(一日增加1公斤或一周增加2公斤以上)時要警覺。
5. 動靜脈瘻管聽不到血流聲或出現紅腫熱痛等感染跡象時需立即處理。

## 四、飲食與活動建議

1. 嚴格限制水分攝取,避免體液過度積聚造成水腫和呼吸困難。
2. 採用低磷飲食,避免食用香腸、火腿、起司、汽水、啤酒、優酪乳等加工食品。
3. 選擇新鮮的雞、鴨、魚、豬里肌肉和嫩豆腐、豆包作為蛋白質來源。
4. 限制鹽分攝取,每日鹽分控制在2-4公克,避免罐頭、醃漬品。
5. 鼓勵適度活動以減少體液滯留,但避免使用動靜脈瘻管的手臂提重物或測量血壓。

## 五、出院追蹤與門診照護導引

1. 需要持續門診治療與追蹤,定期檢查血液尿素氮、血清肌酸酐等腎功能指標。
2. 每日監測血壓、脈搏和體重並詳細記錄,回診時提供醫師參考。
3. 動靜脈瘻管需要每天檢查血流順暢度,聽取血流聲確認功能正常。
4. 定期接受營養師諮詢,根據腎功能變化調整飲食計畫。
5. 如有透析治療,需注意管路照護避免感染,並按照預定時間接受治療。

## 六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

#### ■ 心臟衰竭(ICD-10: I5033)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日測量體重,若一天增加 1 公斤或一週增加 2 公斤以上,需立即聯繫醫療團隊。
- 限制液體攝取(依醫師指示)及鹽分(每日 < 2 公克),戒菸限酒。
- 出現呼吸困難加重、無法平躺、下肢水腫加劇時,需緊急就醫。

#### ■ 慢性腎臟病(ICD-10: N184)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 採低磷、低鉀飲食(視腎功能分期調整),蔬菜煮熟後倒掉湯汁可降低鉀含量。
- 嚴格限制液體及鹽分攝取,避免使用止痛藥(NSAIDs)或來路不明的中草藥。
- 定期回診追蹤腎功能(尿素氮、肌酸酐、電解質),準時接受透析治療(若需要)。

#### ■ 第二型糖尿病(ICD-10: E1152)

- 目前用藥中可能包含降血糖藥或胰島素,請規律監測血糖,並留意冒冷汗、手抖、心悸等低血糖症狀。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 依醫師指示定時測量血糖,餐前目標 80~130 mg/dL,餐後2小時目標 < 160 mg/dL。
- 詳細記錄每次血糖值(日期、時間、餐前/後、藥物劑量),回診時提供醫師調整劑量。
- 每日檢查雙腳皮膚,選擇棉質吸汗襪與寬頭透氣鞋,避免赤腳或穿夾腳拖。

#### ■ 高血壓(ICD-10: I130)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

#### ■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

#### ■ 甲狀腺功能低下(ICD-10: E039)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日固定時間空腹服用甲狀腺素(Levothyroxine),服藥前後1小時避免喝牛奶或服用鈣片。

- 不可自行調整劑量;定期抽血監測 TSH,通常每6個月追蹤一次。

#### ■ 冠狀動脈疾病(ICD-10: I2510)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 隨身攜帶舌下硝酸甘油,胸痛發作時立即含服;若5分鐘未緩解可再含一片,仍無效需緊急就醫。
- 按時服用抗血小板藥物(如阿斯匹靈、Clopidogrel),不可自行停藥。
- 控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子;採低鹽低脂飲食,每週規律有氧運動3次以上。

#### ■ 高尿酸血症/痛風(ICD-10: M109)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 急性發作時,患部冰敷、抬高並休息;遵醫囑使用秋水仙素或類固醇緩解疼痛。
- 少吃紅肉、內臟、海鮮、啤酒等高嘌呤食物;腎功能允許時每日飲水 > 2000 mL。
- 長期降尿酸藥物(Allopurinol 或 Febuxostat)需規律服用,目標尿酸 < 6 mg/dL。

#### ■ 心律不整(ICD-10: I4891)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 避免菸、酒、濃茶、咖啡等刺激性物質,這些可能誘發心律不整。
- 出現持續心悸、胸悶、頭暈、昏厥時,應立即就醫並記錄發作時間與症狀。
- 抗心律不整藥物不可自行調整劑量或停藥,定期回心臟科門診追蹤心電圖。

#### ■ 重度憂鬱症(ICD-10: F329)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 規律服用抗憂鬱藥物,通常需數週才有效果,不可自行停藥;如有副作用請告知醫師。
- 維持規律作息與適度運動(每週3~5次),多接觸陽光,配合心理治療。
- 出現傷害自己或他人的念頭時,這屬於緊急狀況,請立即就醫或撥打緊急電話。

#### ■ 慢性阻塞性肺疾病(ICD-10: J449)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日進行腹式呼吸與噁嘴呼吸訓練,每次10分鐘,每天3次,可增加活動耐力。
- 依醫師指示使用吸入型支氣管擴張劑,正確使用吸藥器是治療關鍵。
- 出現呼吸急促明顯惡化、痰量或痰色改變、發燒時,需立即就醫。

#### ■ 逆流性食道炎(ICD-10: K219)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 飯後不立即平躺,睡前2小時避免進食;抬高床頭約15公分可減少夜間逆流。
- 避免油膩、辛辣、巧克力、咖啡、酒精等刺激性食物。

- 按醫師指示服用制酸劑或質子幫浦抑制劑,即使症狀消失也需依醫囑完成療程。

## 七、參考衛教手冊

1. 末期腎臟疾病
2. 動靜脈瘻管照護(印文版)
3. 低磷飲食
4. 糖尿病足部病變護理指導
5. 心衰竭
6. 傷口照護之護理指導
7. 譫妄-意識混亂
8. 住院病人就醫安全守則
9. 血糖自我監測衛教指導
10. 高血壓
11. 高血脂症護理指導
12. 痛風護理指導
13. 心臟節律不整
14. 憂鬱症
15. 慢性阻塞性肺疾病
16. 逆流性食道炎護理指導

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31